



RÉCAPITULATIF DE MASTERCLASS

Pourquoi vous ne vous sentez plus vous-même après 40 ans ?

Périménopause & ménopause : comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps

Il est temps que tu connaisses ton corps · C'est ta force

12 avril 2026

Ce document rassemble les points essentiels de la masterclass pour que vous puissiez les retrouver facilement, les partager et agir à votre rythme.

MODULE 1

Comprendre ce qui se passe dans ton corps

La transition ménopausique, la réalité des hormones, les acteurs hormonaux et les changements cérébraux documentés par la science.

MODULE 2

Tes symptômes ont une explication

Six symptômes principaux, leurs mécanismes biologiques précis, le syndrome génito-urinaire et l'inflammation de bas grade.

MODULE 3

Ce qui peut vraiment aider

L'épigénétique, les six leviers d'action, le THS, les bilans utiles et le dépistage recommandé.

Amira Medimagh, MD, MPH

Coach en Santé et Nutrition Intégratives

contact@awene.net · www.awene.net

Instagram : @awene_amira_medimagh · Facebook : @AWENE

Comprendre ce qui se passe dans ton corps

LA TRANSITION MÉNOPAUSIQUE

La périménopause ne commence pas avec l'arrêt des règles. Elle s'installe souvent en silence, plusieurs années auparavant. La recherche internationale distingue quatre stades successifs, définis par les critères STRAW+10.

1. **Stade reproductif tardif** — fin 30s–40s — cycles réguliers, changements subtils
2. **Périménopause précoce** — ≈ 47 ans — cycles variant de 7 jours ou plus
3. **Périménopause tardive** — ≈ 49 ans — plus de 60 jours sans règles
4. **Ménopause** — ≈ 51 ans — 12 mois consécutifs sans règles

Les symptômes peuvent précéder tout changement visible du cycle.

LA RÉALITÉ DES HORMONES

Ce qu'on imagine souvent — une baisse progressive et linéaire — ne correspond pas à la réalité biologique. Les hormones fluctuent de façon chaotique, en dents de scie, avant leur chute finale. C'est cette instabilité — et non le niveau bas en lui-même — qui est responsable des symptômes. On parle de profil jagged, documenté par les travaux de Santoro et Prior.

« Ce n'est pas le manque d'hormones qui provoque les symptômes — c'est leur variabilité imprévisible. »

LES ACTEURS HORMONAUX PRINCIPAUX

Trois acteurs principaux orchestrent la transition.

Œstrogène

Véritable carburant du corps féminin, il nourrit le cerveau en glucose, oriente le stockage des graisses vers les hanches plutôt que le ventre, protège les os, le cœur et la peau, et régule le métabolisme énergétique. Quand il fluctue de façon imprévisible, c'est l'ensemble du système qui vacille.

Progestérone

Souvent la première à décliner. Elle produit l'allopregnanolone, molécule apaisante pour le cerveau, calme le système nerveux et est indispensable à un sommeil profond et réparateur. Sa baisse précoce explique l'anxiété, l'irritabilité et les insomnies qui arrivent bien avant les autres symptômes.

Cortisol, sérotonine et GABA

Le cortisol partage le même précurseur que les hormones sexuelles. En stress chronique, il est produit en priorité — aggravant directement le déficit hormonal. La sérotonine et le GABA, régulateurs de l'humeur et du calme, dépendent fortement des œstrogènes pour leur synthèse.

LE CERVEAU EN PÉRIMÉNOPAUSE — DR LISA MOSCONI

La périménopause n'est pas seulement une transition ovarienne. C'est une transition neuroendocrine majeure : le cerveau est aussi impliqué que les ovaires. Les travaux de neuroimagerie de Lisa Mosconi (Weill Cornell Medicine) documentent quatre changements caractéristiques : une réduction du métabolisme cérébral du glucose (hypométabolisme touchant les mêmes zones que dans la maladie d'Alzheimer), un remodelage neuronal comparable à celui de la puberté, un dysfonctionnement de l'hypothalamus à l'origine des bouffées de chaleur, et une neuro-inflammation activant les microglies qui perturbe les neurotransmetteurs.

« Ce n'est pas une dégradation. C'est un remodelage actif : le cerveau se réorganise pour une nouvelle étape de vie. »

Tes symptômes ont une explication

Chaque symptôme que vous vivez pendant la périménopause a une explication biologique précise. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas votre faute. Comprendre le mécanisme, c'est déjà reprendre le pouvoir.

LES SYMPTÔMES ET LEURS MÉCANISMES

Fatigue profonde

Les mitochondries produisent environ 30 % d'énergie en moins. L'inflammation perturbe les neurotransmetteurs, et la résistance anabolique fatigue les muscles en profondeur. Ce n'est pas un manque de motivation — c'est de la biologie.

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes

L'hypothalamus — thermostat interne du corps — se dérègle face aux fluctuations hormonales. Il envoie de fausses alarmes de surchauffe. Plus de 80 % des femmes en transition sont concernées, pour une durée pouvant aller de 2 à 10 ans. Le traitement hormonal substitutif (THS) est à ce jour le traitement le plus efficace.

Brouillard mental

L'œstrogène est le carburant du cerveau. Quand il fluctue, le cerveau souffre d'un déficit énergétique qui affecte la mémoire, la concentration et la vitesse de pensée. 60 à 70 % des femmes en sont touchées. Ce phénomène est documenté par neuroimagerie — il est lié aux hormones, pas uniquement au vieillissement.

Prise de poids abdominale

L'œstrogène orientait le stockage des graisses vers les hanches. Quand il décline, les graisses migrent vers l'abdomen profond — la zone viscérale. Ce n'est pas un manque de volonté : c'est un changement de signalisation hormonale. L'insuline, dont la sensibilité diminue en périménopause, amplifie ce phénomène.

Anxiété et troubles de l'humeur

La chute de progestérone réduit la production de GABA, le calmant naturel du cerveau. Simultanément, la baisse d'œstrogène diminue la sérotonine. Ces deux mécanismes créent une double vulnérabilité émotionnelle. 70 % des femmes rapportent des perturbations émotionnelles significatives.

Troubles du sommeil

Trois mécanismes se combinent : la baisse de progestérone réduit le GABA et rend le sommeil superficiel, les bouffées nocturnes fragmentent les cycles, et la diminution d'œstrogène perturbe la mélatonine via la sérotonine. Un sommeil fragmenté aggrave ensuite tous les autres symptômes.

LE SYNDROME GÉNITO-URINAIRE — LE SYMPTÔME DONT ON NE PARLE PAS

Le déclin de l'œstrogène provoque un amincissement des tissus vaginaux et une hausse du pH, entraînant l'effondrement des bactéries protectrices *Lactobacillus*. Un tiers des femmes de plus de 50 ans sont concernées par sécheresse, inconfort, douleurs et infections urinaires répétées. Contrairement aux bouffées de chaleur, le SGM ne s'améliore pas spontanément avec le temps — il s'aggrave. Des traitements locaux efficaces et bien tolérés existent.

« Le SGM ne s'améliore pas seul avec le temps. Il s'aggrave. Des traitements efficaces existent. »

LE FIL ROUGE : L'INFLAMMATION DE BAS GRADE

Derrière la fatigue, le brouillard mental, les douleurs articulaires et la prise de poids, un mécanisme commun : l'inflammation chronique de bas grade. La perte de protection anti-inflammatoire liée au déclin des œstrogènes, combinée aux cytokines pro-inflammatoires sécrétées par la graisse viscérale (IL-6, TNF- α , CRP), installe une inflammation systémique silencieuse qui aggrave l'ensemble des symptômes. Le stress oxydatif augmente de 50 à 80 % lors du déclin de l'estradiol.

« L'alimentation anti-inflammatoire est le premier levier sur lequel agir. »

Ce qui peut vraiment aider

Tes gènes ne sont pas ton destin. L'épigénétique montre que tes choix quotidiens — alimentation, mouvement, gestion du stress, sommeil — modifient directement l'expression de ton ADN. Chaque femme est unique : ces leviers sont des points de départ à adapter, avec l'accompagnement d'un professionnel de santé.

LES SIX DOMAINES D'ACTION

Alimentation anti-inflammatoire

Le modèle méditerranéen — notre héritage tunisien — est déjà un modèle anti-inflammatoire. L'oléocanthal de l'huile d'olive extra-vierge bloque les mêmes enzymes que l'ibuprofène. Les oméga-3 des poissons gras créent des résolvines qui résolvent activement l'inflammation. Les polyphénols des fruits et légumes colorés inhibent NF-κB, le chef d'orchestre moléculaire de l'inflammation. À réduire voir éliminer : sucres raffinés, huiles industrielles, aliments ultra-transformés, alcool.

Glycémie et insuline

Après 40 ans, l'insuline pèse davantage que les calories dans l'équation du stockage. Manger les protéines et les légumes avant les glucides réduit le pic glycémique de 30 à 40 %. Un jeûne nocturne de 12 à 14 heures améliore la sensibilité à l'insuline. Un apport protéique suffisant (1,1 à 1,5 g/kg/jour) est essentiel pour préserver la masse musculaire.

Exercice et mouvement

La musculation est prioritaire (3 fois par semaine) — pas uniquement le cardio. Elle préserve la masse musculaire, active les transporteurs du Glucose (GLUT-4) et stimule la densité osseuse. Le cardio intensif prolongé élève chroniquement le cortisol et peut aggraver le déficit hormonal. Le HIIT (High Intensity Interval Training) court (20–30 secondes), la marche quotidienne et le yoga sont documentés comme efficaces et bien tolérés.

Système nerveux et stress

Le cortisol et les hormones sexuelles partagent la prégnénolone. En stress chronique, le cortisol est produit en priorité. La cohérence cardiaque (5 minutes, 3 fois par jour) réduit le cortisol salivaire de 20 à 30 % en une seule séance. La TCC (thérapie cognitivo-comportementale) réduit de 50 % la gêne liée aux bouffées. L'hypnose clinique a montré une réduction de 74 % de leur fréquence.

Supplémentation ciblée

Le DHA (≥50 mg/jour, en continu) est un oméga 3 et est le nutriment fondamental du cerveau. En Tunisie, 0 femme sur 258 n'atteignait les niveaux recommandés en vitamine D, avec une moyenne de 7,88 ng/mL malgré l'ensoleillement. Le méthylfolate (5-MTHF) est la seule forme de B9 qui traverse la barrière hémato-encéphalique. Le zinc et le magnésium bisglycinate complètent ces apports essentiels. Toute supplémentation doit être validée avec un médecin.

Environnement et perturbateurs endocriniens

Certaines substances imitent ou bloquent les hormones. Les parabènes, phtalates et BPA/BPS sont présents dans les cosmétiques et plastiques courants. En Tunisie, 100 % des raisins et 62 % des oranges testés contenaient des résidus de pesticides. Vérifier ses cosmétiques (ewg.org/skindeep), privilégier le verre et l'inox, tremper les fruits 15 minutes dans une solution de bicarbonate (10 g/L) réduit jusqu'à 96 % des résidus de surface.

LE TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF

En 2002, l'étude WHI a semé une peur massive et durable autour du THS. Pourtant, cette étude présentait cinq erreurs majeures : l'âge moyen des participantes était de 63 ans, les hormones utilisées étaient synthétiques (dérivés équins), la voie d'administration était orale, la population était asymptomatique, et l'étude a été arrêtée prématurément. En 2022, la FDA a supprimé son propre avertissement, le qualifiant officiellement de trompeur. La réévaluation sur 18 ans de suivi confirme que le THS bioidentique, utilisé dans la fenêtre thérapeutique (avant 60 ans et dans les 10 ans suivant la ménopause), n'a aucun effet négatif sur la mortalité. En Tunisie, les options disponibles sont l'œstrogène transdermique (Estreva®, Femsept®, Thaïs®) avec progestérone micronisée (Utrogestan®). Des alternatives existent pour celles qui ne peuvent ou ne souhaitent pas l'utiliser.

« La peur du THS en 2025 repose sur une étude de 2002 mal interprétée. La décision se prend avec un médecin. »

LES BILANS ET DÉPISTAGES ESSENTIELS

Le dosage hormonal (FSH, estradiol) n'est pas recommandé en périménopause après 45 ans : les hormones sont erratiques par définition et le diagnostic est clinique.

Ce qui compte vraiment : bilan métabolique complet (glycémie, insulinémie, lipides, CRP), TSH thyroïdienne, fer et ferritine (31,2 % des Tunisiennes sont anémiques), et densitométrie osseuse (23,4 % des Tunisiennes de 50 ans et plus ont une ostéoporose).

Pour le dépistage des cancers féminins: mammographie tous les 2 ans dès 50 ans (54,4 % des cancers du sein en Tunisie surviennent en post-ménopause), et test HPV-ADN dès 30 ans, tous les 5 à 10 ans.

Plan d'action & Références

TON PLAN D'ACTION — LA RÈGLE DU UN

Un seul changement à la fois. Tenu 21 jours minimum. Avant d'en introduire un deuxième.

Cette semaine

- Remplacer un aliment ultra-transformé par jour
- 10 minutes de marche après le dîner
- Même heure de coucher pendant 7 jours

Ce mois-ci

- Bilan médical : glycémie, TSH, fer et ferritine, lipides
- Discuter de la supplémentation avec un médecin
- Mammographie ou test HPV si non fait depuis 2 ans

Dans 3 mois

- Intégrer 2 séances de musculation par semaine
- Pratiquer la cohérence cardiaque 5 minutes le soir
- Consulter un médecin avec les données actualisées sur le THS

« Le plus important n'est pas de tout faire. C'est de commencer quelque chose — et de le tenir. »

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Module 1

STRAW+10 — Harlow et al., Menopause, 2012
Santoro N. et al., J Clin Endocrinol Metab, 1996
Prior JC, Endocrine Reviews, 1998
Mosconi L., The Menopause Brain, Avery/Penguin, 2024
IMS — Panay et al., Climacteric, 2025

Module 2

Bikman B., Why We Get Sick, 2020
Yu et al., 2025 — SWAN Study — Soares CN, Menopause, 2013
Kravitz HM & Joffe H., Obstet Gynecol Clin N Am, 2011
NAMS/ISSWSH, Menopause, 2014
McCarthy MM & Raval AP, J Neuroendocrinol, 2020

Module 3

De Vega WC et al., Frontiers in Aging, 2024
Liu X. & Guo Y., Frontiers in Nutrition, 2025
Bikman B., 2020 — Shukla AP et al., Diabetes Care, 2015
Sims ST, Next Level, 2022 — Belgacem A., PAMJ, 2016
McCraty R., Applied Psychophysiology, 2015
Ayers B. et al., Menopause, 2012 — Elkins GR, Menopause, 2013
Naifar M. et al., Ann Biol Clin, 2020 — Hasni Y. et al., Ann Endocrinol, 2018
Fond G., Bien nourrir son cerveau, Odile Jacob, 2025 — WFSBD, 2022
Manson JE et al., JAMA, 2017 — Stute P. et al., Maturitas, 2023
NAMS 2022 — FDA 2022 — HAS sept. 2025
Trasande L. et al., JAMA, 2018 — Nawaat 2024 — Inkyfada 2020
OMS — Cervical Cancer Elimination Initiative, 2030 — FAO/Tunelyz, 2020



Amira Medimagh, MD, MPH
Coach en Santé et Nutrition Intégratives

contact@awene.net · www.awene.net · [@awene_amira_medimagh](https://www.instagram.com/awene_amira_medimagh) · [@AWENE](https://www.facebook.com/AWENE)